

SÉCURISATION DU SUPPORT TRANSFUSIONNEL APRES UN CHOC ANAPHYLACTIQUE CHEZ UN PATIENT POLYTRANSFUSÉ ATTEINT DE LEUCEMIE AIGUE BIPHENOTYPIQUE : A PROPOS D'UN CAS

Y.O. DJEGHRI ¹, K. BOUZENDA ¹, Y. BOUFLOUGHA ¹.

¹ Centre d'hémobiochimie et transfusion sanguine (CHTS), CHU Constantine, Algérie
Email : Djeghriyara@gmail.com

INTRODUCTION

Les réactions anaphylactiques transfusionnelles sont des complications rares mais potentiellement fatales. Chez les patients atteints d'hémopathies malignes nécessitant des transfusions répétées, elles représentent un défi majeur car elles compromettent la poursuite du support transfusionnel en imposant des mesures spécifiques pour prévenir les récurrences.

OBJECTIF

L'objectif de ce travail est de rapporter un cas de réaction transfusionnelle sévère chez un patient polytransfusé et souligner l'intérêt des produits sanguins labiles (PSL) déplasmatisés ou lavés dans la sécurisation des transfusions ultérieures.

OBSERVATION

- Il s'agit d'un patient âgé de 68 ans suivi pour une leucémie aiguë biphénotypique, dépendant de transfusions répétées de concentrés de globules rouges (CGR) et de concentrés plaquettaires, qui présente lors d'une transfusion un état de choc anaphylactique sévère aiguë avec arrêt cardiorespiratoire nécessitant une prise en charge réanimatoire immédiate associant massage cardiaque externe, administration d'adrénaline, de corticoïdes et d'antihistaminiques.
- Après prise en charge de l'épisode aigu, l'interrogatoire a révélé la survenue de frissons au cours de transfusions antérieures.
- Une enquête étiologique a ensuite été réalisée, comprenant notamment un test de Coombs direct, une recherche d'anticorps irréguliers ainsi qu'un bilan d'hémolyse, revenus négatifs. Le dosage des IgA, indiqué à la recherche d'un éventuel déficit en IgA, n'a toutefois pas pu être réalisé en raison de l'indisponibilité du réactif.
- Compte tenu de la persistance des besoins transfusionnels, une stratégie transfusionnelle reposant exclusivement sur des CGR et des CPA compatibilisés et déplasmatisés a été instaurée.

Cette stratégie a permis la reprise des transfusions sans récurrence de réaction transfusionnelle et avec un bon rendement transfusionnel.

DISCUSSION

- Après une réaction anaphylactique sévère, la poursuite du support transfusionnel vital dans la prise en charge des hémopathies impose de réévaluer la stratégie afin de concilier sécurité du patient et continuité des soins.
- Au-delà du traitement de l'urgence, les recommandations internationales insistent sur la réalisation d'une enquête d'hémovigilance afin d'orienter la prise en charge et de prévenir les récurrences.
- Les données de la littérature montrent que ces réactions sont fréquemment liées à une hypersensibilité aux protéines plasmatiques du donneur même si l'allergène responsable reste le plus souvent non identifié ainsi que d'autres mécanismes immunologiques spécifiques tel qu'un déficit en IgA.
- Chez les patients dépendants des transfusions, le recours aux PSL lavés ou déplasmatisés réduit significativement la quantité de plasma résiduel, offrant une stratégie efficace pour limiter l'exposition protéique.
- Notre observation concorde avec ces données, la reprise des transfusions avec des PSL déplasmatisés n'a été suivie d'aucune nouvelle réaction, permettant ainsi la poursuite du support transfusionnel dans des conditions de sécurité satisfaisante.

CONCLUSION

- Ce cas illustre que la survenue d'une réaction anaphylactique sévère ne constitue pas un obstacle définitif au support transfusionnel.
- Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, où la continuité des traitements substitutifs est souvent vitale, les transfusions peuvent être maintenues grâce à une stratégie sur mesure. Celle-ci s'appuie sur le recours à des produits sanguins labiles adaptés, associé à un encadrement rigoureux intégrant prémédication et surveillance clinique renforcée.

Références bibliographiques

- Soutar R, McSporran W, Tomlinson T, Booth C, Grey S. Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions. Br J Haematol. 2023;201(5):832-844. doi:10.1111/bjh.18789.
- International Society of Blood Transfusion (ISBT). Adverse effects of transfusion [Internet]. Amsterdam: ISBT; [cited 2026 Aug 27]
- Güngör H, Uludağ Yanaral T, Uzunoğlu E, Karaaslan P. Anaphylactoid reactions following red blood cell transfusion in a patient with previously undiagnosed immunoglobulin A deficiency: case report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2023;51(2):143-146. doi:10.5152/TJAR.2023.22133.